

Guide d'administration

Protocole Sacituzumab govitecan (*Trodelvy*)

Rédaction : mars 2023 (*Mise à jour avril 2023 : Liste RAMQ*)

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer du sein triple négatif localement avancé non résécable ou métastatique, en monothérapie, chez les patients ayant reçu deux traitements ou plus, dont au moins un en contexte localement avancé non résécable ou métastatique^{1,2} et dont le cancer a progressé pendant ou après l'administration d'une taxane¹.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 1¹.

- › Évaluation de l'INESSS (avril 2022) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mai_2022/Trodelvy_2022_04.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (13 avril 2023):
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole²

Le sacituzumab govitecan est administré aux jours 1 et 8 d'un cycle de 3 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration²

Médicament	Dose	Description
Sacituzumab govitecan	10 mg/kg Jours 1 et 8	› I.V. soluté; dans 250 à 500 mL de NaCl 0,9% (pour obtenir une concentration finale entre 1,1 – 3,4 mg/mL). › Perfusion initiale : sur 3 heures. › Perfusions subséquentes : sur 1 à 2 heures si perfusion précédente bien tolérée. › Protéger le sac de la lumière.
› <i>Répéter aux 21 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.</i>		
Prémédications obligatoires ^{2,3} :		
› Acétaminophène 650 à 1000 mg PO › Diphenhydramine 25 à 50 mg PO ou IV ou équivalent › Famotidine 20 mg PO ou IV ou équivalent › Corticostéroïde si réaction lors de perfusion précédente (ex. : ajout d'hydrocortisone 50 mg IV ou équivalent ou augmentation de la dose de dexaméthasone donnée en prévention des nausées et vomissements)		
Considérations spéciales :		
› Il est recommandé d'observer le patient durant la perfusion et jusqu'à 30 minutes suivant la fin de chaque perfusion².		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique modéré (30-90%)^{2,3}
 - Il est à noter que le sacituzumab govitecan est parfois classifié comme hautement émétisant et que certains auteurs recommandent d'administrer d'emblée une prophylaxie incluant un antagoniste NK-1 ou de le considérer en présence de facteur de risque²⁻⁵.
 - Pré-chimiothérapie: Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
 - Post-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3.
 - Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- › **Réactions reliées à la perfusion² :**
 - Des réactions d'hypersensibilité sont survenues chez plus du tiers des patients durant la perfusion de sacituzumab govitecan et jusqu'à 24 heures après. Les réactions sont habituellement d'intensité légère.
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - Il est recommandé d'administrer une prémédication avant chaque perfusion et d'observer le patient durant et jusqu'à 30 minutes suivant chaque perfusion ([Voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

Prise en charge des réactions liées à la perfusion⁶

Grade*	Prise en charge
1 (symptômes légers)	Ralentir le reste de la perfusion
2 (symptômes modérés)	Interrompre la perfusion. Administrer traitement symptomatique. Lors de la résolution de la réaction, reprendre la perfusion à vitesse réduite. Ajouter corticostéroïde en prémédication lors des perfusions subséquentes ² .
3 ou 4 (symptômes sévères)	Cesser le sacituzumab govitecan définitivement. Administrer traitement symptomatique.

*CTCAE v4.03

› Symptômes cholinergiques²

- Des symptômes cholinergiques tels que diaphorèse, salivation accrue, larmolement, bouffées vasomotrices ou crampes abdominales peuvent se manifester durant ou immédiatement après l'administration du sacituzumab govitecan. L'atropine 0,4 mg SC peut être administrée et répétée si besoin jusqu'à une dose totale de 1 mg⁵. L'administration prophylactique est alors recommandée pour les traitements suivants. La tension artérielle et le rythme cardiaque doivent être surveillés.

› Surveillance des diarrhées²

- Hydratation orale.
- En cas de diarrhée légère à modérée, le lopéramide est utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique (max de 8 co/jour).
- Si diarrhée sévère, le lopéramide à dose élevée pourrait être prescrit : 4 mg dès la première diarrhée, suivi de 2 mg aux 2 heures le jour (4 mg aux 4 heures la nuit). Cesser après 12 heures sans épisode de diarrhée⁵.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale³

Sacituzumab govitecan	Ajustement posologique recommandé
Clcr > 30 mL/min	100 % de la dose
Clcr ≤ 30 mL/min	Non étudié*

*L'élimination rénale du métabolite actif SN-38 est minimale³.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{2, 3, 7}

Bilirubine		AST	Ajustement posologique recommandé
Insuffisance hépatique légère			
≤1,5 x LSN	et	Peu importe*	100 % de la dose
Insuffisance hépatique modérée à sévère**			
>1,5 x LSN	et	Peu importe*	Non étudié

*Les patients inclus dans l'étude devaient avoir une bilirubine ≤ 1,5 x LSN et des AST/ALT ≤ 3,0 x LSN (≤ 5,0 x LSN si présence de métastases hépatiques)⁶

** L'exposition au SN-38 peut être accrue chez ces patients en raison de la baisse de l'activité d'UGT1A1 hépatique².

AST : aspartate aminotransférase; ALT : alanine aminotransférase; LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de doses*,²

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau - 2
Sacituzumab govitecan	10 mg/kg	7,5 mg/kg	5 mg/kg

*Si la dose est réduite suite à un effet indésirable, celle-ci ne doit pas être ré-escaladée par la suite².

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique²

Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1			
$\geq 1,5$	ET	≥ 50	100% de la dose
1 - $< 1,5$ 0,5 - $< 1,0^*$	ET/OU	$< 50^*$	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$, puis reprendre à la même dose. Envisager l'ajout du filgrastim en cas de neutropénie. <u>*Si récupération en 1 semaine ou moins (sinon, voir ci-dessous)</u>
$< 1,0^{**}$ $< 0,5$ (≥ 7 jours) Neutropénie fébrile	ET/OU	$< 50^{**}$	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$ et reprendre avec dose réduite d'un niveau. <u>**Si récupération en 2 à 3 semaines.</u> Si retard de traitement de plus de 3 semaines, cesser le traitement. Ajouter filgrastim en cas de neutropénie.
Jour 8			
$\geq 1,0$	ET	≥ 50	100% de la dose
$< 1,0^{***}$	ET/OU	< 50	Retarder le jour 8 ad neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$, puis reprendre à la même dose si retard de ≤ 1 semaine (sinon débiter un nouveau cycle) OU Omettre le jour 8 (selon jugement clinique ^{***}) Envisager l'ajout du filgrastim et/ou une diminution du niveau de dose

***Selon consensus d'expert

3.5 Ajustement des doses selon la diarrhée²

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé*
1	Augmentation < 4 selles/jour de plus que la normale	Initier ou optimiser traitement antidiarrhéique. Poursuivre le traitement à 100% de la dose.
2	Augmentation de 4 à 6 selles/jour de plus que la normale	
3	Augmentation ≥ 7 selles/jour de plus que la normale ; incontinence ; hospitalisation requise ; interfère avec AVQ	Initier ou optimiser traitement antidiarrhéique. Si non contrôlé par traitement antidiarrhéique, interrompre le traitement jusqu'à un retour à grade ≤ 1 puis réduire la dose d'un niveau.
4	Conséquences menaçant le pronostic vital	Si retard de traitement de plus de 3 semaines, cesser le traitement.

AVQ : activité de la vie quotidienne

*Version CTCAE 4.03

3.6 Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 et 4 (ex. nausées et vomissements non contrôlés par antiémétiques et autres toxicité persistant 48 heures malgré thérapie de support optimale)²

Grade*	Ajustement posologique recommandé
3	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à grade 1 ou moins puis réduire la dose d'un niveau. Si retard de traitement de plus de 3 semaines, cesser le traitement.
4	

*Version CTCAE 4.03

4 Monitoring

4.5 Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être sévère avec le sacituzumab govitecan. Elle peut nécessiter une réduction de dose et l'ajout de filgrastim en prophylaxie secondaire (voir [section 3.4 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). Dans l'étude pivot, 49 % des patients ont reçu du filgrastim et la **neutropénie fébrile** est survenue dans 6 % des cas. L'**anémie** est aussi possible, mais d'intensité légère. La **thrombocytopénie** est survenue rarement².

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité modérée et nécessitent une prophylaxie antiémétique (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)). Il est recommandé d'ajuster la dose de sacituzumab govitecan en cas de nausées et vomissements réfractaires à une thérapie antiémétique optimale ([voir section 3.6 – Ajustement des doses selon la toxicité non-hématologique](#))².

Des **symptômes cholinergiques** tels que diarrhée, diaphorèse, salivation accrue, larmoiement, bouffées vasomotrices ou crampes abdominales peuvent se manifester durant ou immédiatement après l'administration du sacituzumab govitecan ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))².

La **diarrhée** est fréquente. Le délai médian d'apparition est de 19 jours⁷. En cas de diarrhée, il convient d'exclure une cause infectieuse, puis de débiter thérapie antidiarrhéique. Si diarrhée réfractaire à la thérapie antidiarrhéique, il est recommandé d'ajuster la dose de sacituzumab govitecan ([voir section 3.5 – Ajustement des doses selon la diarrhée](#)). La **constipation** est également possible².

Les patients avec **polymorphisme génétique** du gène UGT1A1 (ex. : homozygote pour l'allèle UGT1A1*28) sont exposés à un risque plus important de toxicité (ex. : neutropénie, neutropénie fébrile, anémie)². Il est à noter que le génotypage de l'UGT1A1 n'est pas recommandé avant l'initiation du traitement^{2,5} et n'est pas fait de routine au Québec.

Les **réactions reliées à la perfusion** de sacituzumab govitecan, survenant pendant ou dans les 24 heures suivants la perfusion, ont été rapportées chez 34 % des patients². Les réactions sévères sont rares (1%)² et se sont manifestées par les signes et symptômes suivants : hypotension, respiration sifflante, angioœdème, enflure, réactions cutanées, pneumonite et arrêt cardiaque. Il est recommandé d'administrer une prémédication pour prévenir cette réaction et d'observer le patient durant et suivant chaque perfusion (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#) et [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Le sacituzumab govitecan peut occasionner une **toxicité dermatologique** qui se manifeste par un rash maculopapulaire, érythémateux, acnéiforme et peut être accompagné de prurit⁵. Un corticostéroïde topique et un antihistaminique oral peuvent être prescrits.

L'**alopécie** est survenue chez 46 % des patients¹.

Il n'y a aucun cas rapporté d'**extravasation** pour le moment avec le sacituzumab govitecan. De par sa structure chimique, il est raisonnable de penser qu'il serait non-irritant ou irritant (extravasation)⁷.

Tableau des effets indésirables^{1,8}

Effets indésirables* n=258	Tous grade (%)	Garde 3 (%)	Grade 4 (%)
Neutropénie	63	34	17
Diarrhée	59	10	0
Nausées	57	2	< 1
Alopécie	46	-	-
Fatigue	45	3	0
Anémie	34	8	0
Vomissements	29	1	< 1
Toux	24	0	0
Diminution de l'appétit	20	2	0
Céphalée	18	1	0
Dyspnée	17	3	< 1
Constipation	17	0	0
Leucopénie	16	9	1
Hypokaliémie	16	3	0
Douleur au dos	16	1	0
Pyrexie	15	< 1	0
Infection urinaire	13	< 1	0
Asthénie	12	1	0
Rash	12	< 1	0
Arthralgie	12	< 1	0
Hypomagnésémie	12	0	0
Infection des voies respiratoires supérieures	12	0	0
Augmentation des AST	11	3	0
Douleur abdominale	11	1	0
Insomnie	11	0	0
Stomatites	10	1	0
Augmentation des ALT	10	1	0
Prurit	10	0	0
Étourdissements	10	0	0
Neutropénie fébrile	6	5	1
Thrombocytopénie	5	1	1

*Version CTCAE 4.03

4.6 Interactions cliniques significatives^{2,3}

Le sacituzumab govitecan est un conjugué anticorps-médicament. Il est composé de l'anticorps hRS7 lié à la charge SN-38 (métabolite actif de l'irinotecan) par un lien hydrolysable (CL2A)⁷. Le SN-38 est substrat de l'UGT1A1².

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs de l'UGT1A1	↑ de l'exposition au SN-38	Utiliser avec prudence. Monitorer étroitement les effets indésirables.
Inducteurs de l'UGT1A1	↓ de l'exposition au SN-38	Si possible, éviter la co-administration (diminution possible de l'efficacité du traitement)
Vaccins vivants	Risque de développer une infection	Éviter la co-administration

4.7 Suivis de laboratoire et examens²

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, AST/ALT, bilirubine, électrolytes (Ca, K, Mg)
Avant chaque traitement (Maximum 72 heures avant le jour 1 et 24 heures avant le jour 8)	FSC, créatinine, AST/ALT, bilirubine, électrolytes (Ca, K, Mg)

5 Références

1. Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, Loirat D, Punie K, Oliveira M et coll. Sacituzumab Govitecan in metastatic triple-negative breast cancer. *N Engl J Med* 2021;384:1529-41.
2. Gilead Sciences Canada. Monographie de Sacituzumab govitecan (Trodelvy). Mississauga (Ontario). 2 août 2022.
3. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 13 février 2023.
4. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Antiemesis. Version 1.2023. Clinical Practice Guidelines in Oncology. Plymouth Meeting, PA : NCCN; 2023. Disponible à : https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/.
5. Spring LM, Nakajima E, Hutchinson J, Viscosi E, Blouin G, Weekes C et coll. Sacituzumab Govitecan for metastatic triple-negative breast cancer: Clinical overview and management of potent toxicities. *The Oncologist* 2021;26:827-34.
6. Protocole de : Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, Loirat D, Punie K, Oliveira M et coll. Sacituzumab Govitecan in metastatic triple-negative breast cancer. *N Engl J Med* 2021;384:1529-41.
7. Gilead Medical Information. Gilead Sciences Inc. Personal Communication: Trodelvy® (sacituzumab govitecan) Programme de formation sur le sacituzumab govitecan. 9 mars 2023.
8. Supplementary Appendix to : Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, Loirat D, Punie K, Oliveira M et coll. Sacituzumab Govitecan in metastatic triple-negative breast cancer. *N Engl J Med* 2021;384:1529-41.